	Governo de Estado do Acre Secretaria Estadual de Saúde do Acre Departamento de Vigilância em Saúde Centro de Operações de Emergências em Saúde
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	
DATA: 28/03/2024 **HORÁRIO:** 9h **LOCAL:** Sala de Reunião do 4º Andar	
PAUTA/ASSUNTO:	Cenário Epidemiológico de Síndromes Respiratórias no Acre 2024
PARTICIPANTES:	**Presencial** 1 – Marcos Malveira 2 – Débora dos Santos 3 – Adriana Lobão 4 – Emanuelly Nobrega 5 – Relben Ferreira 6 – Maressa Guimarães 7 – Jamayla Silva 8 – Domisy Araújo **Online** 1 – Pablo Araújo (Alto Acre) 2 – Diani Carvalho (Alto Jurua) 3 – Deusdete Souza- DSEI ALTO RIO JURUÁ 4 – Bruno Cordero - DSEI ALTO RIO PURUS 5 – Rosineide Monteiro (Ponto Focal do SRAG / CIEVS)

SÍNTESE DOS ASSUNTOS TRATADOS:

Marcos (COES) apresentou a situação epidemiológica das doenças respiratórias no estado do Acre, destacando que a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) tem registrado um aumento de notificações, principalmente entre indivíduos de 20 a 29 anos. Foi mencionado que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito ficou as últimas três semanas sem realizar coletas, mas retomou essa atividade no dia 27 de abril de 2024. A SRAG é atualmente a maior preocupação e já está em alta, com sua sazonalidade prevista para ocorrer entre as semanas 14 a 16.

Bruno Meireles, do Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Purus (DSEI ARP), informou que foram registrados 100 casos de síndrome gripal (SG), mas que estes não estão evoluindo para casos mais graves, sendo a maior parte tratável no território sem registros de óbitos por SG. Entretanto, foram notificados de 5 a 6 óbitos infantis por outras causas.

Deusdete, do DSEI Alto Rio Juruá (DSEI ARJ), e Marcicleide reportaram que as notificações estão dentro do esperado, com cerca de 100 a 120 casos, e um óbito em Feijó de uma criança de 11 meses por infecção respiratória aguda (IRA) e desidratação.

Marcos questionou sobre a existência de Planos de Contingência para SRAG nos DSEI e qual seria o fluxo de notificação, se iria primeiro para a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) ou diretamente para a Sala de Situação. Júlio mencionou a ausência de Planos para as Síndromes Gripais e indicou que a comunicação seria feita da Sesacre para atendimento e posteriormente para a SESAI.

Outros pontos abordados incluem a necessidade de dialogar com outras coordenações, mencionada por Érica do Departamento de Atenção Primária, e a situação estrutural e de recursos humanos nos hospitais, trazida por Pablo da Coordenação Regional do Alto Acre. Diani, da Coordenação Regional do Juruá Tarauacá Envira, destacou a manutenção de contato com as

Vigilâncias Hospitalares e reportou um óbito por bronquiolite em Marechal Thaumaturgo, além de alertar sobre a alta de infecções respiratórias agudas e severas (IRAS e IVAS).

Emanuelly, do Departamento de Atenção Especializada, falou sobre a capacitação in loco e o manejo dos protocolos clínicos do Ministério da Saúde, enquanto Domisy enfatizou a importância da capacitação e qualificação na Atenção Básica. Jamayla, Diretora de Planejamento e Gestão do SUS, mencionou o esforço para levantar a necessidade de medicamentos e insumos e a ampliação de leitos em Sena Madureira e no Hcamp.

Marcos reforçou que a Sala de Situação é um canal aberto para a preparação e coordenação entre todos os entes envolvidos no combate às doenças respiratórias no Acre.

PRÓXIMA REUNIÃO:	A definir

ENCAMINHAMENTOS	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Nenhum			

ANEXOS:

OBSERVAÇÕES:

Nenhuma